
Disfunção Temporomandibular

Disfunção Temporomandibular (DTM)

Resumo de estudo para Odontologia

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Conceitos Fundamentais e Fatores Gerais	3
02 Trauma, Hábitos Parafuncionais e Postura	4
03 Sono, Genética, Condicionamento Físico e Nutrição	5
04 Hidratação, Cafeína, Álcool, Gênero e Psicologia	6
05 Dor na DTM e Mecanismos de Sensibilização	7
06 Classificação das DTM Articulares e Musculares	9
07 Diagnóstico Clínico e Conduta	10
08 Referências	12

01

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Conceitos Fundamentais e Fatores Gerais

PONTOS-CHAVE

Função normal: sistema mastigatório executa suas funções vitais (mastigação, fonação, deglutição) sem dor ou limitações.

Fator etiológico contribuinte: qualquer condição com potencial de alterar essa função. Nem sempre gera dor, pois depende da tolerância fisiológica.

Adaptação: quando fatores estão presentes, mas não há sinais ou sintomas clínicos de DTM.

Tolerância fisiológica: capacidade de músculos, ATM e ligamentos resistirem às agressões sem manifestar disfunção.

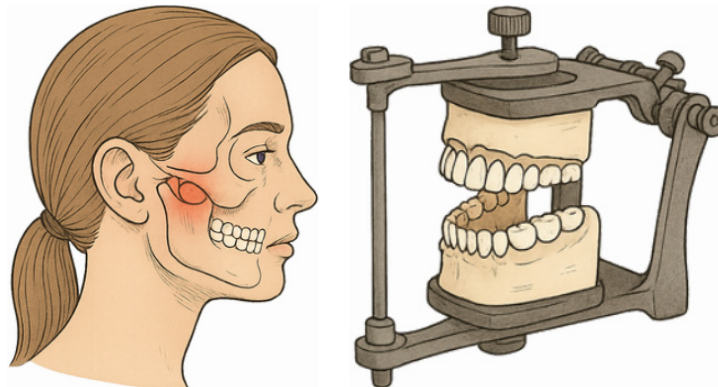
Má oclusão:

Não é causa direta de DTM.

Pode atuar como fator agravante de hábitos parafuncionais.

Ex.: má oclusão não causa bruxismo, mas pode intensificar seus efeitos sobre os dentes e a ATM

Conceito-chave: A DTM é uma condição multifatorial, que resulta da interação de diversos fatores: mecânicos, biológicos, psicológicos e ambientais.



ANOTAÇÕES

02

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Trauma, Hábitos Parafuncionais e Postura

Traumas:

PONTOS-CHAVE

Macrotraumatismos: ocorrem de forma súbita e intensa (acidente automobilístico, pancada direta).

Microtraumatismos: ocorrem de forma repetida e prolongada (bruxismo, postura inadequada, apertamento).

Danos dependem de intensidade, frequência e duração do trauma.

Hábitos parafuncionais:

Atividades musculares fora da mastigação/fala.

Em vigília (conscientes): roer unhas, mascar chiclete, morder objetos.

Inconscientes (sono): bruxismo noturno.

Jaw play: movimentos mandibulares sem propósito definido.

Efeitos:

Sobrecarga muscular → fadiga, dor.

Desgaste dentário → altera oclusão.

Mudanças na posição da língua/postura mandibular.

Diagnóstico: questionários, exame clínico, polissonografia, eletromiografia.

Postura:

Cabeça anteriorizada → aumenta tensão cervical, perpetua dor miofascial e ativa trigger points.

Postura inadequada do sono → favorece compressão mandibular.

Recomendação: travesseiro macio sob cabeça/pescoço, apoiado no ombro; outro travesseiro sob braço para evitar rotação do ombro.



ANOTAÇÕES

03

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Sono, Genética, Condicionamento Físico e Nutrição

Qualidade do sono:

PONTOS-CHAVE

Sono não reparador = despertares frequentes, fragmentação, cansaço ao acordar.

Sem estágio 3 → não ocorre restauração muscular, nem liberação adequada de hormônios (serotonina, GH).

Consequências clínicas:

Fadiga muscular, dor e tensão.

Ansiedade e depressão associadas.

Sensibilidade musculoesquelética.

Genética:

Determina morfologia facial (maxila/mandíbula posicionadas de forma anormal).

Pode predispor a alterações musculares ou doenças inflamatórias.

Geralmente atua em conjunto com fatores ambientais (trauma, hábitos).

Condicionamento físico:

Exercícios aeróbicos e alongamentos → aumentam oxigenação, reduzem dor.

Liberam opioides endógenos → efeito analgésico natural.

Previnem estresse e melhoram qualidade de vida.

Nutrição:

Refeições muito espaçadas → hipoglicemia.

Hipoglicemia → ativa pontos algícos, causa cefaleia e dor miofascial.



ANOTAÇÕES

04

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Hidratação, Cafeína, Álcool, Gênero e Psicologia

Água:

PONTOS-CHAVE

Consumo insuficiente → desidratação → ativação de pontos álgicos.

Recomendação: ~2 litros/dia, divididos ao longo do dia.

Cafeína:

Estímulo excessivo do SNC → intensifica dor.

Causa desidratação → piora dor miofascial e ativa trigger points.

Álcool:

Atua como depressor do SNC → sensação inicial de relaxamento.

Efeitos negativos: prejudica arquitetura do sono e causa desidratação.

Agrava cefaleias e sintomas miofasciais.

Gênero:

Mulheres são mais sensíveis à dor durante menstruação, ovulação e gestação.

Hormônios reprodutivos (estrógeno e progesterona) modulam percepção da dor.

Alterações psicológicas na gravidez podem intensificar sintomas.

Psicológicos:

Estresse, ansiedade, depressão, catastrofização.

Afetam sono, aumentam percepção da dor e favorecem a cronificação.

Ciclo vicioso: dor ↔ estresse ↔ piora da função mastigatória.



ANOTAÇÕES

05

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Dor na DTM e Mecanismos de Sensibilização

PONTOS-CHAVE

Dor aguda: curta duração, resposta imediata.

Dor crônica: longa duração, prejudica sono e aumenta sensibilização central.

Sensibilização central:

Fibras sensitivas → alodínia.

Fibras motoras → contrações protetoras.

Fibras autonômicas → vermelhidão, edema, congestão nasal, lacrimejamento.

Co-contração protetora:

Resposta inicial a estímulos dolorosos.

Características: dor leve, fraqueza, dificuldade de abertura bucal.

Reversível se fator causador for eliminado.

Dor muscular local:

Primeira resposta inflamatória.

Características: dor mínima em repouso, limitação de abertura, dor em palpação/função.

Dor miofascial:

Inflamação mais acentuada, envolvimento muscular e nervoso.

Trigger points: áreas hipersensíveis em feixes musculares rígidos.

Ativação por estresse, posturas, hipoglicemia, desidratação, estados febris, fibromialgia.

Dor referida:

Masseter → dor em dentes posteriores.

Trapézio → cefaleia temporal, dor retroauricular.

Diagnóstico: dor reproduzida por palpação.



ANOTAÇÕES

06

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Classificação das DTM Articulares e Musculares

DTM Musculares:

PONTOS-CHAVE

Dor muscular local (processo algogênico).
Dor miofascial (local + referida, trigger points).
Mioespasmo (contratura dolorosa).
Miosite (inflamação muscular).

DTM Articulares:

Mecânicas:

Deslocamento de disco com redução: estalido, sem dor, sem limitação.
Deslocamento de disco sem redução: limitação (25–30 mm), deflexão, perda de estalidos.
Aderências, adesões, subluxações.

Inflamatórias:

Sinovite/Capsulite: dor lateral e pré-auricular, limitação.

Retrodiscite: edema, dor pós-condilar, desocclusão posterior ipsilateral.

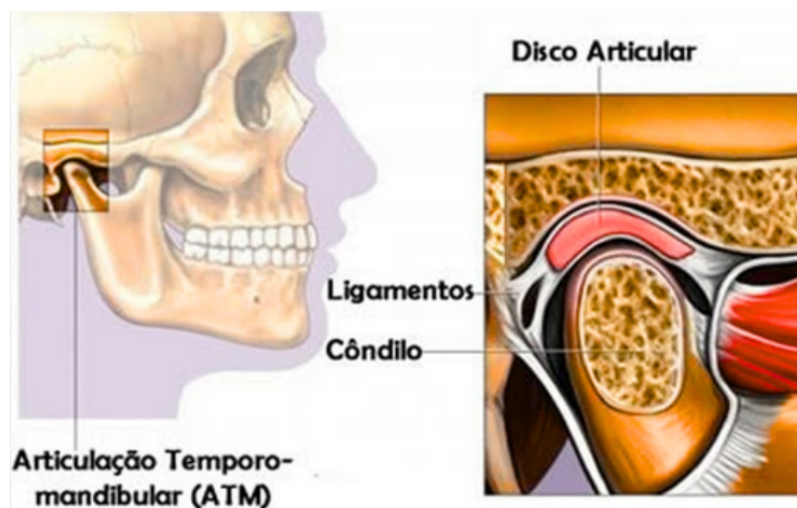
Osteoartrite: crepitação, dor durante função, alterações ósseas radiográficas → pode evoluir para osteoartrose.

Diagnóstico diferencial:

Desvio = disco com redução.

Deflexão = disco sem redução.

Teste de carga: dor ipsilateral → muscular; dor contralateral → articular.



ANOTAÇÕES

07

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Diagnóstico Clínico e Conduta

Etapas do diagnóstico:

PONTOS-CHAVE

Identificação da queixa principal.

Anamnese completa:

Histórico médico/cirúrgico (doenças como fibromialgia, artrite reumatoide).

Medicamentos atuais/passados (efeitos, doses).

Aspectos psicossociais (ansiedade, lazer, atividade física).

Qualidade do sono (PSQI).

Histórico familiar (artrites, migrânea).

Histórico odontológico (traumas, tratamentos prévios, acidentes).

Histórico ocupacional (profissão, estado civil, filhos).

Hábitos parafuncionais (bruxismo, roer unhas, segurar objetos com dentes).

Mudanças recentes (emprego, finanças, casamento, luto).

Caracterização da dor: início, localização, intensidade (EVA), duração, frequência, qualidade, fatores de melhora/piora, sintomas associados, resposta a tratamentos prévios.

Exame físico:

Inspeção cabeça/pescoço (assimetria, linfonodos).

ATM: trajetória mandibular, amplitude, sons (estalidos, crepitação).

Palpação calibrada: 0,5 kg (ATM lateral), 1 kg (músculos).

Avaliação cervical (trapézio, esternocleidomastoideo).

Exame intraoral: facetas de desgaste, mucosa jugal, vitalidade dentária.

Pares cranianos se necessário.

Exames complementares:

RM → tecidos moles.

TC feixe cônico → tecidos duros.

Solicitados apenas se alteram conduta.

Conduta final:

Avaliação multidimensional (biológica, psicológica, social).

Identificação e controle de fatores desencadeantes/perpetuadores.

Diagnóstico precoce → previne cronificação da dor.



ANOTAÇÕES

08

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)

Referências

MACHADO, Luiz Cláudio da Silva; BIANCHINI, Eduardo Maria. **Disfunção Temporomandibular: Diagnóstico e Tratamento**. São Paulo: Santos, 2012.

ANOTAÇÕES